EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70339
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-09-06 09:24:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN RAMIRO FIGUEROA RUBIO			RUN	: 7.581.039-3
F.Nac	: 18-05-1955	Edad	: 68 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 30-08-2023	Fecha Egreso	: 2023-09-06 09:24:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. T06.0-TRAUMATISMOS DEL ENCEFALO Y DE NERVIOS CRANEALES CON TRAUMA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

TEC grave
HIC lobar frontal izq. parasagital con hemoventriculo
hematoma subdural parafacino izq no QX
Trabronquitis x SAMR tradada
HTA}DM2 IR
OH cronico
Disfagia severa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. T06.0-TRAUMATISMOS DEL ENCEFALO Y DE NERVIOS CRANEALES CON TRAUMA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente el 8/8/23 presento súbito compromiso de conciencia luego de TEC.
Consulto inicialmente a SU de HSC, posteriormente fue derivado a HCHM, ingresa en sopor superficial, afasia global y debilidad de hemicuerpo derecho, se realizo TAC de encéfalo donde se evidncio HIC lobar frontal izquierdo con hemoventriculo + hematoma subdural para falcino izquierdo. Fue evaluado por neurólogo quien refiere que no es de resorte quirúrgico.
El 13/08/23 presento caída de la escala de Glasgow, se tomó TAC de control el cual no presenta nuevas lesiones. Ingresó a UCI Qx para manejo neurocrítico. Se realizo IOT con sedoanalgesia.
Presento elevación de parámetros inflamatorios y fiebre se pancultivo e inicio cenftriaxona + clindamicina.
UC+ para E. fecalis se asjusto terapia a ampicilina, presistio febrilse realizo CSB + para SAMR por lo cual se escala a vancomicina, con buena respuesta.
Se extubo el dia 21/08, ex neurológico vigil, afasia global, mirada a izquierda. Plegia braquicrural derecha y monoparesia crural izq. NIHSS 25.
TAC 24/8/23: HIC subagudo del cíngulo izquierdo con hemoventriculo sin resangrado. Evaluado por fonoaudiología quien informa disfagia severa que requiere SNG.
El 30/08/23 fue derivado desde HCHM para realizar neurorehabilitación.

Paciente actualmente en mejor estado general, tranquilo,
mas conectado que día anterior, conectado con mirada, sigue ordenes sencillas
Movimiento de ESI. Hemodinamicamente estable, sin apremio ventilatorio
Afebril, diuresis + deposiciones +.

Ex físico:
Paciente mas conectado que ayer, ojos abiertos, sigue mirada, pupilas isocoricas
Movilidad de ESI.

Piel rosada, mucosas hidratadas, llene capilar <3s
Cardiopulmonar: RR2T NAS. MP+ SRA
Abdomen: RHA+ abdomen BDI, sin signos de irritación peritoneal.

PLAN DE MANEJO:

1.- Mantener Neurorehabilitacion con HODOM
2.- Control con neurologia, interconsulta ya cursada
3.- Control en Cae de cirugia en 21 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. 1.- Reposo relativo, levantar asistido
2. 2.- Regimen papilla + 1000 ml de agua dia fraccionada
3. 3.- Neurorahabilitacion por HODOM; KNT + Fonoaudiologia
4. 4.- Bromuro de ipratropio 2 puff c/8h inhalatorio
5. 5.- SAlbutamol 2 puff c/8h inhalatorio
6. 6.-FENITOINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
7. 7.-LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
8. 8.-SERTRALINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. 9.-AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. 10.-QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
11. 11.-OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
12. 12.- COntrol con neurologia al alta, se realiza interconsulta
13. 13.- Control en cae de cirugia en 21 dias

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO